TD4 Indices cliniques et organisation des observations

Support de travail établi à partir des documents transmis. Le rattachement Moodle a été vérifié sur la liste des ressources ; les fichiers Moodle non récupérés et les commentaires audio ne sont pas déclarés intégralement contrôlés.

Cours et application

Travail demandé

À partir de la séquence du film Hippocrate, construire un outil pour regrouper les données ayant un point commun, nommer les catégories et expliquer le classement au groupe. Plusieurs organisations sont possibles si elles sont cohérentes et justifiées.

Faits observés

Distinguer dispositifs, positions, mouvements, expressions du visage, paroles ou réponses gestuelles. Écrire par exemple « secoue la tête de droite à gauche » avant de proposer une interprétation. La compréhension et la signification du geste restent à vérifier.

Interprétation

Un visage crispé, des gémissements ou une agitation peuvent orienter vers une douleur ou un inconfort. Ils constituent des indices à explorer ; ils ne prouvent ni une cause unique ni un diagnostic. L’absence de parole ne prouve pas l’absence de compréhension.

Classement possible

Données physiques et dispositifs ; mobilité et autonomie ; communication ; vécu émotionnel ; relation et environnement ; besoins et risques. Un même fait peut concerner plusieurs catégories si son lien est expliqué sans le compter plusieurs fois comme preuve indépendante.

Relation et consentement

Observer comment la personne accepte ou refuse les interactions. Rechercher une communication accessible, présenter le soin et vérifier l’accord. Un geste de retrait doit être exploré avec tact ; ne pas conclure, à partir d’une image seule, à un refus global de tous les soins.

Présentation orale

Présenter l’objectif de l’outil, les catégories retenues et deux exemples de liens. Séparer ce qui est vu de ce qui est supposé. Terminer par les informations manquantes qui permettraient d’affiner l’analyse.

Élaborer une matrice d’observation

Le TD demande de transformer les observations d’une séquence en une organisation lisible. Commencer par une liste descriptive sans chercher immédiatement un diagnostic. Relever ce qui est visible ou audible, puis identifier la source des informations qui proviennent d’un échange entre personnages.

Des catégories possibles sont : état physique et dispositifs, mobilité et autonomie, communication, vécu émotionnel, relation et environnement. Une autre organisation est recevable si elle permet de retrouver les données et d’expliquer les regroupements. La qualité du raisonnement compte davantage qu’un nombre imposé de cases.

Une main attachée relève de la mobilité et du contexte de soins. Une sonde est un dispositif observé ; sa fonction ou sa tolérance ne peut être affirmée qu’à partir des éléments disponibles. Un visage crispé ou des gémissements peuvent constituer des indices d’inconfort. Chaque lien doit rester explicite.

Séparer trois niveaux : fait observé, hypothèse et information à vérifier. Par exemple : « gémit lors d’un geste » ; hypothèse de douleur ; recherche complémentaire sur localisation, intensité et contexte. Cette distinction empêche de présenter une impression comme une certitude.

Présenter et discuter l’outil

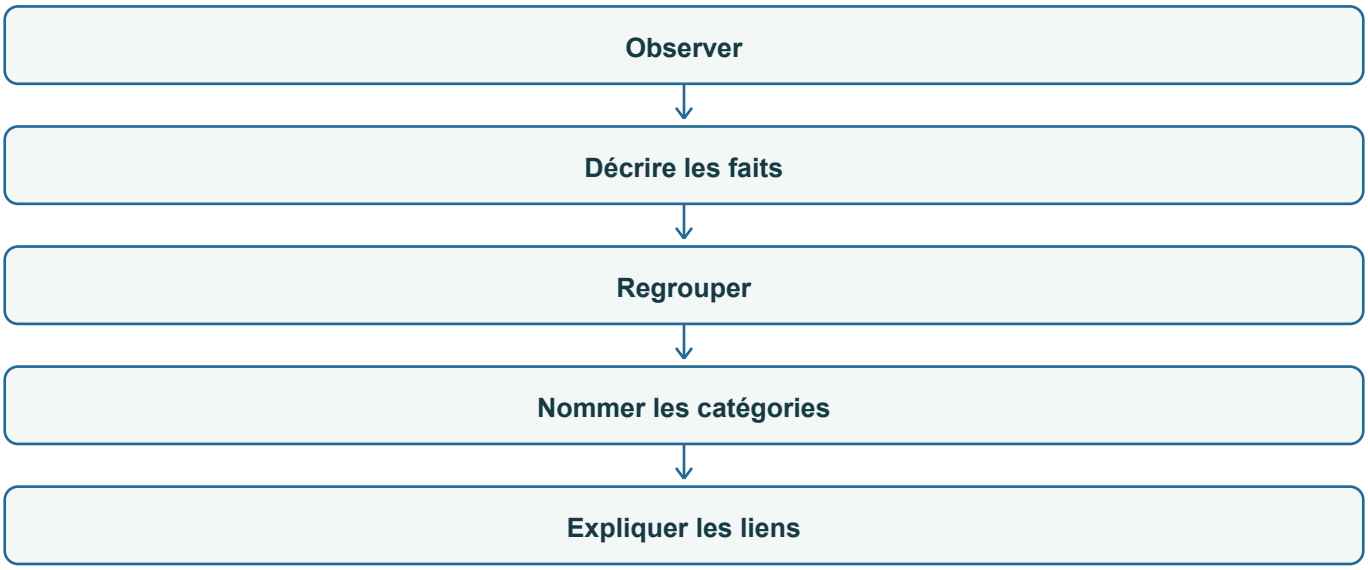
Pour l’oral, présenter d’abord la logique de classement. Montrer comment deux observations ont été regroupées et pourquoi. Si une donnée concerne plusieurs dimensions, expliquer le lien sans la multiplier artificiellement comme plusieurs preuves d’une même hypothèse.

La communication non verbale doit être interprétée prudemment. Un mouvement de tête peut exprimer un accord, un refus ou une autre intention selon la question posée. Une absence de parole n’établit pas à elle seule un trouble cognitif. Rechercher un moyen de vérifier la compréhension et le sens du message.

Les images fournies sont des outils de mise en forme des observations ; elles ne sont pas une preuve supplémentaire indépendante du film. Certains libellés sont interprétatifs. Ne pas conclure à un refus global de soins palliatifs sur la seule base d’un comportement ou d’une fiche graphique.

Terminer par les informations manquantes : ce que la personne ressent, ce qui gêne, les capacités habituelles, les objectifs du soin et le contexte relationnel. Une matrice doit aider à poursuivre le recueil et à discuter les priorités, sans remplacer la parole de la personne.

Schéma et vérification des acquis



Questions et réponses

Une sonde suffit-elle à conclure à une dénutrition ? Non.

Quel écrit est factuel ? « Gémit lors de la mobilisation », plutôt que « fait du cinéma ».

Pourquoi nommer les catégories ? Pour rendre les données retrouvables et le raisonnement explicite.

Sources et portée

UE A1 TD 4.docx

Ressource Moodle correspondante